



OBESIDADE

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESCVI

APV&E EDUCACIONAL
**UNI
NOVAFAPI**
CENTRO UNIVERSITÁRIO

OBJETIVOS:

- 1. Compreender o conceito, classificação, diagnóstico, abordagem e recomendações da obesidade e sobrepeso na APS.*

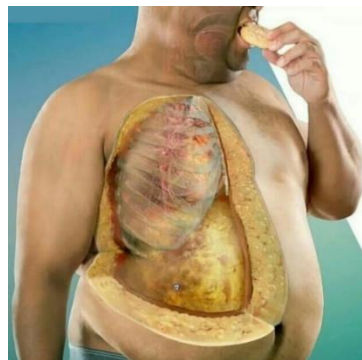
- É o acúmulo excessivo de gordura corporal causada pelo balanço energético positivo, isto é, a ingestão calórica excede o gasto calórico.
- Esse balanço positivo pode resultar do excesso crônico de ingestão energética, da redução crônica do gasto, ou, mais comumente, de ambos.

Se a ingestão excede o gasto energético, ocorre um balanço positivo, com deposição energética e tendência ao ganho de peso; se a ingestão é inferior, ocorre um balanço negativo com depleção dos depósitos energéticos e tendência à perda de peso.

- Acarreta repercussões à saúde, com perda importante na qualidade de vida do indivíduo, bem como no aumento de comorbidades.
- É considerada a doença nutricional mais frequente.

- O excesso de peso acomete um em cada dois adultos e uma em cada três crianças brasileiras.
- Sua prevalência aumenta com a idade e é mais comum no sexo feminino, em pessoas de baixa renda, com grau de instrução correspondente ao ensino médio, ou inferior, e em negros.
- Paradoxalmente, as populações mais pobres, antes mais predispostas à desnutrição, agora estão evidenciando altas frequências de obesidade.
- Com raras exceções, o pobre de hoje não come pouco, mas come mal.

- Em grande parte, isso ocorre porque os alimentos industrializados costumam ter alto valor energético e menor custo, ao contrário de alimentos frescos e mais saudáveis, como frutas, verduras e legumes, que são também mais perecíveis.
- O local onde a gordura se acumula tem repercussões em suas complicações, sendo que a obesidade abdominal é mais associada ao diabetes e à doença vascular.
- Entre suas causas, estão relacionados fatores biológicos, históricos, ecológicos, econômicos, sociais, culturais e políticos.



- O acúmulo de gordura pode ser mensurado por meio do índice de massa corporal (IMC):

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso (em kg)}}{\text{altura}^2 \text{ (em metros)}}$$

- O IMC correlaciona-se com os fatores de risco à saúde e é utilizado para classificar o grau de obesidade.



- Com o aumento da idade, ocorrem modificações na composição corporal como diminuição de água corporal, massa óssea, massa muscular, redistribuição da gordura corporal e redução progressiva de altura.

VALORES DO IMC: PESSOAS ACIMA DE 60 ANOS

VALOR DO IMC	CLASSIFICAÇÃO
<i>Menor que 22</i>	<i>Baixo peso</i>
<i>De 22 a 27</i>	<i>Normal</i>
<i>De 27 a 29,99</i>	<i>Sobrepeso</i>
<i>Maior que 30</i>	<i>Obesidade</i>

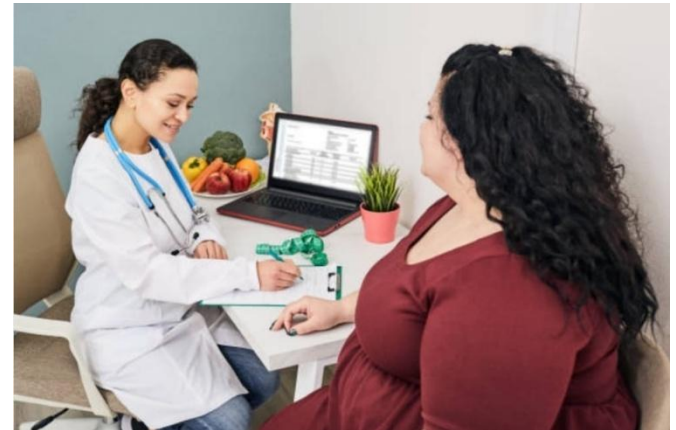
- O IMC, como medida de excesso de peso, tem mostrado uma correlação linear com:
 - ❑ Risco de doença cardiovascular (DCV);
 - ❑ Desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2);
 - ❑ Hipertensão arterial sistêmica (HAS);
 - ❑ Doença da vesícula biliar.
- Além desses riscos, a obesidade é também associada a vários tipos de câncer, a doenças osteomusculares, pulmonares e reprodutivas.



ANAMNESE

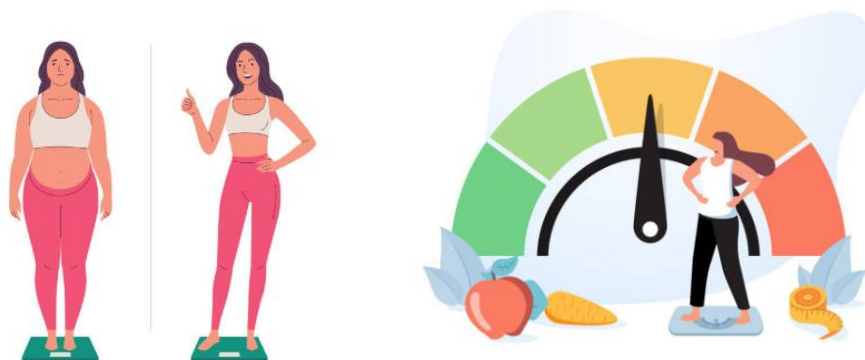
Na avaliação inicial, deve ser investigada a história do excesso de peso:

- ❑ Idade de início;
- ❑ Maior e menor pesos alcançados;
- ❑ História familiar de obesidade;
- ❑ Tentativas anteriores de emagrecimento - sucessos obtidos e fatores precipitantes das recaídas.



- É necessário conhecer:

- ❑ Estilo de vida investigando sobre comportamento alimentar e padrão de atividade física pessoal e familiar.
 - ❑ As expectativas relacionadas ao peso desejado (quanto a pessoa espera pesar ao final do tratamento e a velocidade de perda esperada).
 - ❑ As consequências da perda de peso dos pontos de vista psíquico e físico.
- As consequências físicas são avaliadas pela presença de comorbidades, como DM2, hipertensão, DCV, osteoartrite, dislipidemia, apneia do sono e outros problemas clínicos.



- Raramente, a obesidade pode estar associada a causas secundárias.
- Na anamnese, devem-se buscar sintomas de:
 - ❑ Doenças endócrinas: sintomas de hipotireoidismo, síndrome de Cushing, acromegalia.
 - ❑ Uso de medicamentos associados ao ganho de peso: antidiabético, hormônios esteroides, antipsicóticos, estabilizadores do humor, antidepressivos, anticonvulsivantes, betabloqueadores.
 - ❑ Transtornos psiquiátricos: depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, transtorno do humor bipolar, uso de drogas.

Quadro 11 – Doenças endócrinas associadas ao excesso de peso

Doença endócrina	Quadro clínico associado	Comentários
Hipotireoidismo	Fadiga, intolerância ao frio, constipação, bradicardia, rarefação de pelos.	Ganho de peso modesto – não explica obesidade mórbida.
Síndrome de Cushing	Obesidade central, giba, atrofia da pele, estrias violáceas, equimoses.	Rara. Causa mais comum é o uso crônico de corticosteroides.
Síndrome de ovários policísticos	Hirsutismo/hiperandrogenismo, oligo/amenorreia, resistência insulínica.	Relação causa-efeito com a obesidade não está estabelecida.
Deficiência de hormônio do crescimento (GH)	História de deficiência de GH na infância. Pan-hipopituitarismo associado (tumor de hipófise, craniofaringioma).	Rara. Tratamento indicado apenas quando as manifestações clínicas são graves.
Obesidade hipotalâmica	Cefaleia, alteração visual, infertilidade, convulsão, sonolência, alterações de comportamento, diabetes <i>insipidus</i> , insuficiência adrenal.	Muito rara. Associada a trauma, a tumor, doença inflamatória, à manipulação cirúrgica de fossa posterior ou à hipertensão intracraniana.

Quadro 19 – Medicamentos associados ao ganho de peso

Medicamentos associados a ganho de peso	
Psicofármacos	Antipsicóticos típicos – clorpromazina
	Antipsicóticos atípicos – risperidona, clozapina, olanzapina
	Estabilizadores de humor – lítio, ácido valproico, carbamazepina
	Antidepressivos tricíclicos – amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtazapina
	Inibidores seletivos da receptação de serotonina – paroxetina
	Antiepiléticos – valproato de sódio
	Benzodiazepínicos – diazepam, alprazolam e flurazepam
Antidiabéticos	Insulina
	Sulfonilureias – glipizida, tolbutamida, clorpropamida
Hormônios	Corticosteroides
	Medroxiprogesterona



HISTÓRIA CLÍNICA

Razão principal da consulta: excesso de peso ou complicação do excesso de peso

História do ganho de peso: nasceu grande ou pequeno; o excesso de peso teve início na infância, adolescência, gravidez ou menopausa; houve ganho recente?

História de tentativas de perda de peso

Atividade física

Hábitos e transtornos alimentares

Revisão dos sistemas: sintomas de hipotireoidismo (pele seca, fadiga, intolerância ao frio), síndrome de Cushing, diabetes, doença cardiovascular, doença do refluxo gastresofágico, alterações reprodutivas ou articulares, doenças de pele, cálculos biliares, problemas do sono

Uso atual de fármacos obesogênicos: antipsicóticos atípicos (em especial olanzapina e clozapina), antidepressivos (sobretudo amitriptilina, mirtazapina e paroxetina), corticosteroides, progestágenos, betabloqueadores, hipoglicemiantes orais, anticonvulsivantes (fenitoína, valproato), insulina, anti-histamínicos (especialmente os de primeira geração)

História familiar de diabetes e obesidade

História familiar de doença cardiovascular precoce (infarto ou AVC)

EXAME FÍSICO

- O IMC é recomendado como uma estimativa prática de sobrepeso em adultos, mas necessita ser interpretado com cautela porque não é uma medida direta da adiposidade.
 - ❑ Em adultos com grande massa muscular, o IMC superestima a adiposidade.
- Não se recomenda como rotina o uso da bioimpedância para medida da adiposidade geral.
- A avaliação da gordura abdominal – medida da circunferência – deve ser usada em adultos com IMC menor do que 35 kg/m².



Homens: normal < 94 cm; aumentada 94-102 cm; muito aumentada > 102 cm.
Mulheres: normal < 80 cm; aumentada 80-88 cm; muito aumentada > 88 cm.

- No exame físico, devem-se buscar sinais de doenças associadas à obesidade secundária:

- ☐ Pele seca, fria e descamativa;
- ☐ Cabelos finos e secos;
- ☐ Voz rouca;
- ☐ Madarose;
- ☐ Edema duro;
- ☐ Presença de bócio;
- ☐ Obesidade centrípeta e com giba;
- ☐ Presença de acantose nigricante;
- ☐ Estrias purpúricas;
- ☐ Aspecto facial característico de acromegalia com prognatismo e feições rudes, mãos grandes e com aumento dos tecidos moles.



- Em crianças e adolescentes, o limite de normalidade é estabelecido por curvas de percentil do IMC, nas quais o sobrepeso corresponde ao IMC entre 85 e 95% para faixa etária e sexo, e a obesidade corresponde ao valor acima de 95%.





EXAME FÍSICO

Peso, altura, cintura, quadril e pressão arterial (com manguito adequado)

Pele e subcutâneo: dobras de pele e pés (micoses superficiais); textura do subcutâneo (edema com cacifo; mixedema, com sensação borrachenta)

Sinais da síndrome de Cushing: face “em lua cheia” e pletórica, pescoço em ogiva, equimoses

EXAMES COMPLEMENTARES

- Em geral, é suficiente a medida de perfil lipídico e glicemia.
- Quando existe suspeita de doenças causando a obesidade, deve-se proceder à investigação apropriada.





EXAMES COMPLEMENTARES

Glicemia de jejum e, quando maior risco, teste de tolerância à glicose

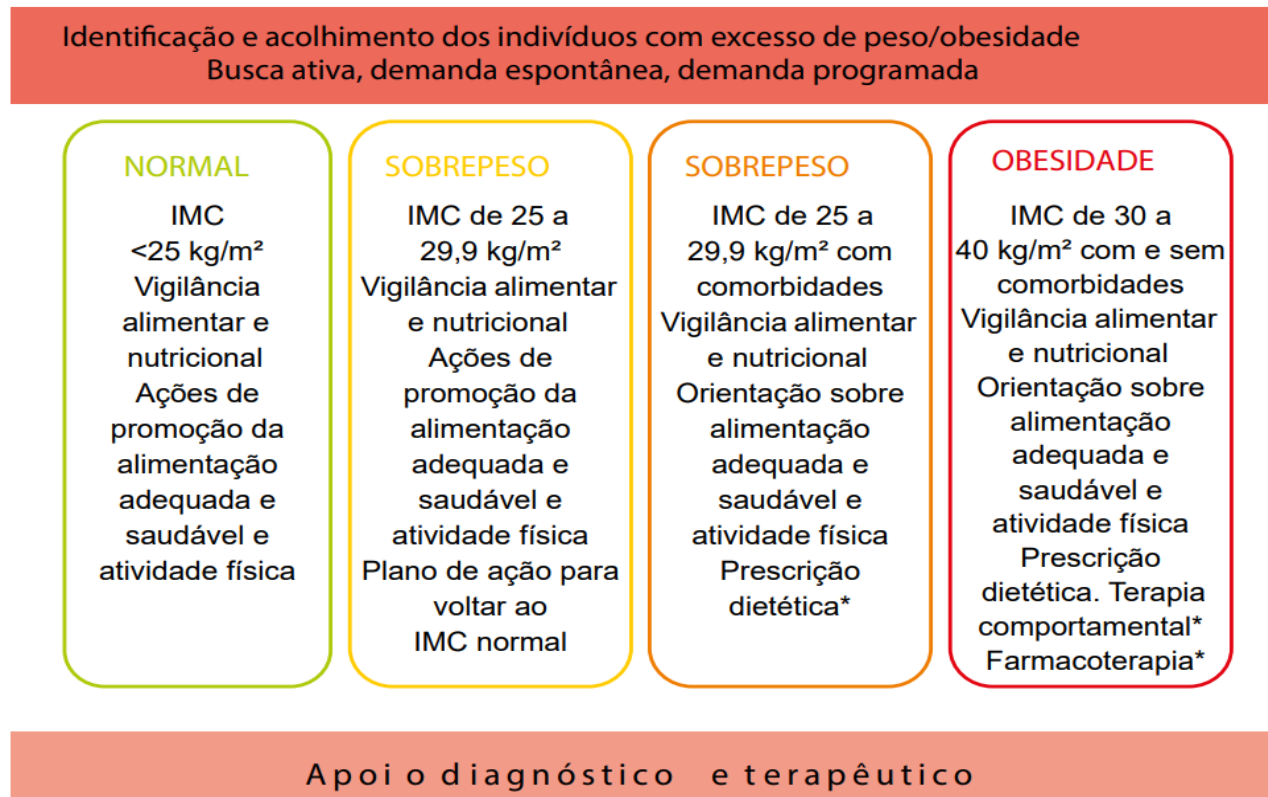
Colesterol total

TRATAMENTO

- Intervenções que mostraram eficácia na redução ponderal em relação a placebo são dieta hipocalórica, exercício físico, aconselhamento intensivo individual ou em grupo, farmacoterapia e cirurgia bariátrica.
 - ❑ Essas intervenções reduzem os fatores de risco para doenças crônicas.
- O tratamento é lento, e o acolhimento pela equipe de saúde nos momentos de insucesso e o estímulo para reiniciar o tratamento são essenciais para o benefício em longo prazo.
- As mudanças comportamentais necessárias à perda de peso só serão possíveis em pessoas motivadas.
 - ❑ É necessário avaliar se a pessoa deseja perder peso e oferecer informações e apoio, respeitando sua autonomia.

- A posição de orientar todas as pessoas e tratar mais intensivamente aquelas com fatores de risco tem sido a mais expressa nos consensos.

Figura 1 – Fluxograma descritivo de atividades para a Atenção à Saúde, segundo classificação do IMC na Atenção Básica para indivíduos adultos



TRATAMENTO NUTRICIONAL

- No momento em que o profissional da saúde pretende orientar o indivíduo a alterar seus hábitos alimentares, ele está assumindo um compromisso, que precisa de consultas periódicas, novas orientações e estímulos para manter o tratamento e as modificações agregadas à sua vida.
- Existem vários tipos de dietas e todas podem ser benéficas, se forem adequadas individualmente.
- O mais importante, no momento da escolha do cardápio é o balanço energético negativo e a capacidade de mantê-lo pelo período proposto.



ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

em dez passos



Faça diariamente
3 refeições
&
2 lanches



Prefira os
grãos
integrais

Coma todos
os dias:

3 porções
de legumes
e verduras

3

porções
de frutas



Refrigerantes,
sucos industrializados,
biscoitos, bolos
e outras guloseimas

2

vezes por semana



consuma no máximo
uma porção
de azeite, manteiga
ou margarina



Consuma
diariamente

1

porção
de leite
ou derivados

5

Coma arroz
e feijão
vezes
na
semana

Reduza o
consumo de

sal

(Para ajudar, retire
o saliera da mesa)

Beba pelo menos
2 litros
de água
por dia

Evite as bebidas
alcoólicas e o cigarro.
Faça
30 minutos
de atividade
física por dia



TRATAMENTO COMPORTAMENTAL

- Baseia-se em análise e modificações de comportamentos disfuncionais associados ao estilo de vida da pessoa.
- O objetivo é implementar estratégias que auxiliem no controle do peso, reforçando a motivação e ajudando a evitar a recaída.



- **Automonitoramento** - Registro por escrito realizado pela própria pessoa sobre o tipo e a quantidade dos alimentos ingeridos, incluindo horários, episódios compulsivos, fatores desencadeantes, pensamentos e sentimentos relacionados.
- **Controle dos estímulos** - Planejamento de estratégias que favoreçam a modificação de comportamentos disfuncionais.
 - Ex.: Planejar as compras de alimentos, aumentar a atividade física, planejar atividades novas em horários habituais de compulsão.
- **Reestruturação cognitiva** - Consiste em identificar crenças e pensamentos disfuncionais com relação ao peso e à alimentação.



ATIVIDADE FÍSICA

- O exercício físico promove benefícios antropométricos, metabólicos, neuromusculares e psicológicos.
- Quando realizado de forma regular:
 - ❑ Melhora a resistência cardiorrespiratória, o perfil lipídico, o bem-estar geral, a energia.
 - ❑ Auxilia no controle do DM2.
 - ❑ Reduz riscos cardiovasculares, mesmo quando não ocorre perda de peso.
- Autoestima, imagem corporal, humor, redução da ansiedade e depressão também são alterados de forma positiva.



- A recomendação atual é a prática de exercícios físicos:
 - ❑ 150 minutos de exercícios moderados por semana para a manutenção do peso e da saúde;
 - ❑ Mais de 150 minutos por semana para promover o emagrecimento e evitar a recuperação do peso.
- Quanto às crianças e aos adolescentes, também existe a necessidade de serem criados programas de incentivo à prática de esportes.
- O nível de atividade física e o tempo que a criança fica em frente à televisão têm sido associados com a ocorrência de sobrepeso/obesidade infantil.



TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

- Há, no mercado, uma série de medicamentos que podem ser utilizados na redução de peso.
- É importante salientar para a pessoa que os medicamentos são auxiliares na redução de peso e que seu uso não substitui a reeducação alimentar associada à atividade física, assim como a necessidade de visitas regulares à equipe de saúde.
- Não há evidências que comprovem que um fármaco é mais eficaz que outro.

ORLISTAT

- Inibidor da lipase gástrica e pancreática que promove má absorção e reduz a absorção de gorduras em aproximadamente 30%.
- É eficaz em comparação com placebo com uma redução média de peso em 2,7 a 2,9 kg.
- Como efeitos colaterais pode provocar surgimento de gordura nas fezes, flatulência e diarreia, o que, muitas vezes, faz o paciente descontinuar o tratamento.
 - ❑ Esses efeitos indesejáveis podem ser controlados pela redução da gordura na dieta.
 - ❑ Dessa forma, tem papel no treinamento comportamental do manejo da dieta.

- Não apresenta risco cardiovascular, podendo ser usado em pacientes cardiopatas, assim como em crianças obesas acima de 12 anos.
- Está contraindicado na gestação e em pacientes com má absorção crônica.
- É apresentado em comprimidos de 120 mg, que devem ser utilizados com as refeições principais três vezes por dia.



SIBUTRAMINA

- Inibidor da recaptação da serotonina, da dopamina e da norepinefrina.
- Age aumentando a saciedade pós-ingestão e a taxa metabólica.
- Perda em torno de 4 a 5 kg em 12 meses.
- Os efeitos colaterais mais comuns são disforia, cefaleia, boca seca, vertigem, insônia, alterações da PA e da frequência cardíaca.
 - ❑ A maioria dos sintomas diminui com o tempo de uso.
- Devido aos efeitos cardiovasculares, não deve ser usado em cardiopatas.
- A dose recomendada é de 10 a 15 mg/dia.



Saxenda®



LIRAGLUTIDA



- É um hipoglicemiante, agonista do peptídeo 1 similar ao glucagon (GLP-1).
- Provoca atraso no esvaziamento gástrico e reduz a ingesta calórica por ação central.
- A dose inicial é 0,6mg em dose única diária em injeção subcutânea.
 - ❑ A dose pode ser aumentada semanalmente até atingir 3 mg.
- A perda ponderal em média varia de 4,2 a 5,9 kg.
- Os efeitos colaterais são náusea, vômitos, constipação, hipoglicemia, diarreia, fadiga, tontura, dor abdominal e aumento dos níveis de lipase.
- Seus principais inconvenientes são a administração parenteral e o alto custo.

BUPROPIONA

- Antidepressivo de uso combinado, dopaminérgico e noradrenérgico, unicíclico.
- A dose recomendada é de 100 a 400 mg/dia.
- A média de perda de peso é de aproximadamente 3 kg entre 6 e 12 meses.
- Os efeitos colaterais mais comuns são insônia, boca seca e tremores; reduz o limiar para convulsões.



METFORMINA

- É um medicamento do grupo das biguanidas que atua aumentando a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, sobretudo no fígado, diminuindo a produção hepática de glicose.
- Em mulheres com sobrepeso ou obesas com SOP, o uso de metformina (1.500 mg/dia) ajuda na redução de peso, reduzindo o IMC em 1 kg/m², uma redução de menos 2,9% do peso.
- Entre os efeitos colaterais estão anorexia e sintomas gastrintestinais.



TOPIRAMATO

- Anticonvulsivante, administrado em doses de 25 a 200 mg/dia.
- Reduz em torno de 8% do peso.
- Entre os efeitos adversos mais comuns estão parestesias, alteração de paladar e disfunção cognitiva.



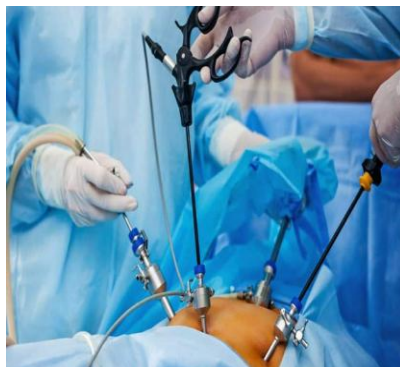
LORCASERINA

- É um agonista seletivo da recaptação de serotonina, que promove saciedade e reduz a ingesta de alimentos.
- É administrado em comprimidos de 10 mg, duas vezes ao dia.
- Promove uma perda ponderal média de 3,2 kg.
- Seus efeitos colaterais são cefaleia, tonturas, fadiga, náusea, boca seca, constipação.
- Em diabéticos, pode provocar hipoglicemia.

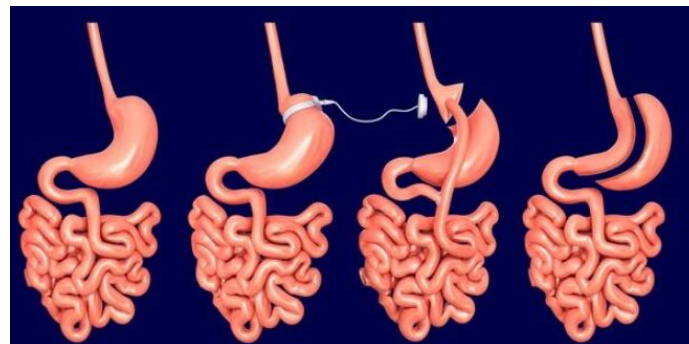


CIRURGIA BARIÁTRICA

- É uma opção de tratamento para pessoas com obesidade mórbida que não obtiveram sucesso por, pelo menos, 2 anos com alteração de hábitos alimentares, atividade física, medicamento ou tratamentos alternativos.
- O objetivo da operação é induzir uma perda de peso substancial – 50 a 80% do excesso de peso – que diminua as comorbidades associadas à obesidade.



- Desde 1999, é realizada pelo SUS.
- Mesmo assim, considerando o potencial de obesos mórbidos, o SUS tem a capacidade de tratar cirurgicamente 0,8% das pessoas, o que significa longas filas de espera e necessidade de tratamento clínico nesse período.
- O bypass gástrico aberto ou por laparoscopia e a gastrectomia vertical laparoscópica levaram à redução do IMC e não houve diferenças consistentes entre as técnicas.





Quadro 176.5 | Detalhes sobre a cirurgia bariátrica

Critérios de indicação

- ▶ Peso: $\text{IMC} > 40 \text{ kg/m}^2$ ou $\text{IMC} > 35 \text{ kg/m}^2$ associado a comorbidades
- ▶ Tratamento por pelo menos 2 anos sem sucesso (incluir programas como Vigilantes do Peso, Centro de Recuperação e Estudo da Obesidade [CREEO], Comedores Compulsivos, Grupos de Emagrecimento)
- ▶ Adesão: expectativa de que a pessoa vai aderir ao tratamento pós-operatório (visitas e acompanhamento com a equipe multidisciplinar, assim como o uso de suplementos alimentares, procedimentos ou testes recomendados)

Critérios de exclusão

- ▶ Distúrbios endócrinos reversíveis ou outros que possam causar a obesidade
- ▶ Abuso de álcool ou drogas
- ▶ Doença psiquiátrica grave ou descontrolada
- ▶ Incapacidade de compreender os riscos, os benefícios, os resultados esperados e as mudanças de estilo de vida

- A recomendação é o acompanhamento de pelo menos 2 anos após a cirurgia.
- A avaliação deve incluir:
 - ❑ Monitoramento da ingesta nutricional e das deficiências minerais;
 - ❑ Monitoramento das comorbidades;
 - ❑ Revisão das medicações;
 - ❑ Avaliação e suporte nutricional;
 - ❑ Avaliação e suporte para atividade física;
 - ❑ Manejo das condições psicológicas.
- O paciente com obesidade que foi submetido à cirurgia bariátrica necessita de acompanhamento contínuo em relação à obesidade, ainda que o peso esteja dentro dos limites adequados.

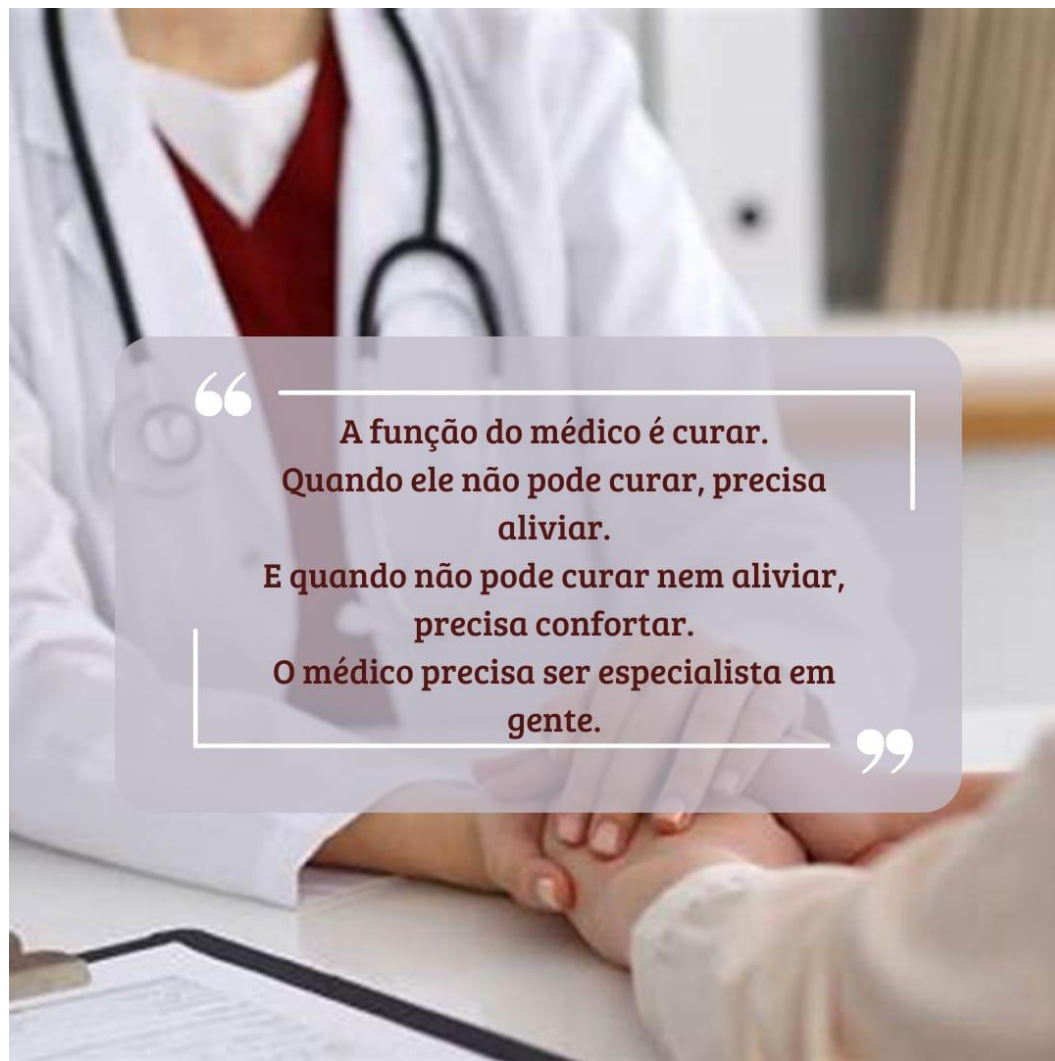
Referências Bibliográficas:

CAB: Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategias_cuidado_doenca_cronica_obesidade_cab38.pdf.

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. Cap. 62.

Guia alimentar (Pode ser aplicado no momento de rastreio): Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_alimentacao_saudavel.pdf.

PDF: Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf>.



“

A função do médico é curar.
Quando ele não pode curar, precisa
aliviar.

E quando não pode curar nem aliviar,
precisa confortar.

O médico precisa ser especialista em
gente.

”

Obrigada!